جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سميه نصر احمد محمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الجيزه **العنوان :** المنصوريه
رقم البطاقة : 28707092101284 **رقم التليفون :** 01116657202 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 09-07-1987 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سميه نصر احمد محمد
National ID: 28707092101284

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





DMS
ونار على البطن والجوز
ونا رو ما سولم
تومينا
فيتامين ١
١٨/٥

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

4-Patient ID:
1- Name : سعيه نصر احمد محمد
Sex: Female
3- Medical number: 83185361
Old Med .
344/2024
2-ID number:
Patient Age : 37 Y

Family history		Phone	01116057202	BMI		REASON OF MDT	
marital status		NRS Score		GROUP		Date of MDT	29/11/24
Co morbidity		Menopausal status	PREMENOPAUSAL	Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :
CESM: LT UOQ mass+ non mass
preserved axillary N

Mets Workup :
CT CAP : Free
boen scan:free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KI67
IDC LT UOQ 11 -FOCAL DCIS	8/8	8/8	2	Amplified	25

T	N	M
CT3	0	0

Sonomammography
CESM ---> L.T UOQ MASS + NON MASS PRESENTED AXILLARY LN

PATIENT HISTORY
ended 6 cycle TC + 5 PHESGO
lt WLE++SLNB :free margin
ypT1c N0 0/5
partial pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

for TDM1 X 1 YEAR
AI ZOLADEX
PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

Name: سمية نصر احمد العطار **MR. :** 748	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

38 Y OLD FEMALE, prem left breast cancer, CT3 no MO, IDC GII, ER 8/8, PR 7/8, HER2 sish amplified. Received TCHP. On 10/2024 left WLE, ypT1, N0/5. Recurrent KADCYLKA, port placed. Kept on Zoladex, Femara. SM 9/2025 left breast mass BIRADS 4c, biopsy no malignancy for Zometa. Zoladex, Femara continued.

SM 5/2026, free PAUS 6/2026, free for Zoladex + Femara for 3 months.

تحريرا في ,

التاريخ :	**21-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : علياء احمد أبو النصر شهاب الدين

يعتمد ,

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and
Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Exam Information:

Patient Name: *Somia Nsr*	***Date of birth:*** *09/07/1987*
Arabic Name: سمية نصر	***Patient Gender:*** *F*
Patient RIS ID: *354599* ***Patient HIS ID:*** *124008510*	***Exam Date:*** *16/05/2024*
Written by: Dr. Hoda Fathy	**Approved by:** Dr. Hoda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (16/5/2024)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP

Revealed:

- No definite evidence of osseous metastatic deposits could be seen over the surveyed skeleton
- Severe degenerative changes over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obliged

Alaa Elsaeed

Mohamed Abdeltawab, MSc

atient Name	: الأستاذه / سميه نصر احمد العطار	Request No.	: 13008398
atient No.	: 28707092101284	Request Date	: 11/01/2024
th No.	: 163/24	Verification Date	: 20/02/2024
ex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
ge	: 36 Y	Department	: Out Patient
eferreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

nical Data: Left breast lesion.
ture of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 10/01/2024, 11:12 am.

oss Examination:
ultiple grayish white tissue cores up to 2 cm, totally submitted.
ections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, . Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

croscopic Examination:
istological type: invasive duct carcinoma.
rade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
uctal carcinoma in situ: Focal.
PT (Positive control showed appropriate reactivity):
R: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
R: Strong nuclear reaction in 85% of tumor cells (score 8/8).
er2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+).
i67: 25% nuclear reaction of tumor cells.
ISH: Amplified.
verage Her2 copy No. > (4.9), Her2/CEP17 ratio > (2.1))

agnosis:
ft breast lesion, Tru-cut biopsy:
asive duct carcinoma, Grade II with focal DCIS component.
r:
R: Positive (score 8/8).
R: Positive (score 8/8).

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

سونار + ماموجرام قبل العملية

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Somaya Nasr Ahmed Mohamed Al Attar	Date : 16/07/2024	
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 37 Year(s)	
Medical ID: 344/2024	Pat. ID: 76340	

DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND;

Indication:

Patient is 37 years old and is seen for Post NACT status assessment of a known left breast malignant masses marked by metallic clip.

Report:

- ACR b: scattered fibro-glandular parenchyma of both breasts
- **Left breast:**
  - A residual ill-defined irregular parenchymal distortion is seen in the left UOQ with overlying malignant microcalcifcations marked by metallic clip (seen at the center of the microcalcifications). The area collectively measures 54x28x34mm. Ultrasound shows residual distortion corresponding to mammographic findings.
  - Stationary probably benign lesions, the largest at 11 O'clock is still measuring 28x13mm.
  - Nonspecific axillary LNs.
  - No pathologically enlarged regional lymph nodes
- **Right Breast:**
  - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
  - No suspicious lesions.
  - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
  - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post NACT status of left breast showing partial response with residual distortion and microcalcifications with no axillary lymphadenopathy (BIRADS 6)
- No suspicious findings of right breast (BIRADS 2)

Best regards,

Dr. Eman Abdel Razik, MSc, FEBR
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University

16/7/2024

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name	: الأستاذه / سميه نصر احمد العطار	Request No.	: 13000129
Patient No.	: 28707092101284	Request Date	: 20/10/2024
Path No.	: 4020/24	Verification Date	: 02/11/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Partial pathologic response
- Stage: ypT1, ypN0.

Signature
Dr. Walaa Ghonaim.
Dr. Yasmine Essam.

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

العينة بره العلبة

Patient Name	: الأستاذه / سميه نصر احمد العطار	Request No.	: 13000129
Patient No.	: 28707092101284	Request Date	: 20/10/2024
Path No.	: 4020/24	Verification Date	: 02/11/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.
Nature Specimen: Left WLE and SLNs.

Gross Examination:
* Left SLN: A fibro fatty tissue piece measured 5x3 cm entangling 5 nodules up to 1x0.5x0.5 cm.
* Left WLE specimen measured 9x6x3 cm, with covering skin ellipse measured 5x1.5 cm
* Tumor extent: A firm ill defined grayish white wited tumor bed site.
- Size: 1.5x1x1 cm
* Distance from margins: 0.5cm from least inked deep margin, 1.5 cm from superior margins, 2 cm from medial and inferior margins, 3 cm from lateral margin, and 2.5 cm from skin.

Microscopic Examination:
* Histological Type: Residual invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: Positive (8%) (high grade and cribriform pattern)
* Lymph node involvement: Negative for metastasis in 0/5 lymph nodes.
* Angioinvasion: Not detected.
* Perineural invasion: Not detected.
* Resection Margins: Free.
* Histologic response to therapy: Partial pathologic response
* Microcalcifications: Positive.

Diagnosis:
Left breast, WLE and SLNs Biopsy:
Residual invasive duct carcinoma, grade II, with high grade DCIS.
- Free surgical resection Margins.
- Negative Lymph nodes in 0/5.

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qademe - Cairo, Egypt

٢٠٢٥/٥/٧

PP:

امانة المراكز الطبية الاختصاصية
مستشفى اورام دار السلام

Echo report

Name: نور حسن
Age: ٢٤٤/٤
Date: ٧/٩ 2025

EF	65%	54-74%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	51	3.5-5.7cm	AO	2.3	2.0-3.7cm
LVESD		2.2-4.0cm	LA	3.2	1.9-4.0cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm (supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions: طبيعي
LV wall thickness: طبيعي
LV diastolic function: طبيعي
SWMA. لا يوجد
LA size طبيعي
Aortic root dimension طبيعي
Mitral Valve طبيعي
Aortic valve طبيعي
Tricuspid valve Trivial TR
Pulmonary valve طبيعي
Right side size and systolic function طبيعي
Intracardiac masses and thrombi لا يوجد
Pericardium طبيعي
IVC diameter and collapsibility. طبيعي
Conclusion:

د. [illegible]

جمعية مسجد د. مصطفى محمود
Dr . Mostafa Mosque Society
الوحدة العلاجية
مركز الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي

مقطعية قبل الجلسة

Name: Somya Nasr Ahmed Date:-6/2/2024

R: 22000

Prof DR.

I-POST CONTRAST C.T. SCAN OF THE CHEST REVEALED :-

- Clear both lungs showing no definite nodules, masses or cavitary lesions.
- Clear both costophrenic recesses .
- Mild cardiomegally with no pericardial effusion
- No evidence of hilar/mediastinal lymphadenopathy .

II-POST CONTRAST C.T. ABDOMEN AND PELVIS REVEALED :-

- Average sized liver showing homogenous texture and regular smooth outlines. No definite focal lesions or dilated IHBRs.
- Patent main portal vein and its central branches.
- Average sized spleen showing no definite focal lesions.
- Normal CT appearance of the pancreas, adrenal glands, kidneys, aorta and IVC.
- Intact pelvic organs.
- No retro-crural or retro-peritoneal lymph nodes are noted.
- No ascites.
- Clear scanned lung bases.

CONCLUSION:-

- **Normal post-contrast CT examination of the abdomen and pelvis.**

Dr. Ahmed Badr **Prof. Dr. Magdy Bassiouni**
S.A